

FEBRASGO POSITION STATEMENT

Tratamento cirúrgico do prolapso apical

Número 9 – 2026

A Comissão Nacional Especializada em Uroginecologia e Cirurgia Vaginal da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) referenda este documento. A produção do conteúdo baseia-se em evidências científicas sobre a temática proposta, e os resultados apresentados contribuem para a prática clínica.

Pontos-chave

- O prolapso genital apical representa uma falha do suporte do nível I de DeLancey.
- A histerectomia vaginal isolada não corrige o prolapso apical.
- Toda cirurgia para prolapso uterino ou de cúpula vaginal deve incluir a suspensão apical.
- A sacrocolpopexia é a técnica com maior durabilidade para a correção do prolapso de cúpula vaginal, com exceção da colpocleise.
- As técnicas vaginais continuam sendo opções válidas em pacientes selecionadas.
- A preservação uterina é possível e segura em pacientes criteriosamente avaliadas e quando baseada em decisão compartilhada.
- O reconhecimento do componente apical em cistoceles avançadas é essencial para evitar a recorrência.
- A correção do hiato genital reduz o risco de recorrência, independentemente da via cirúrgica.
- A cistoscopia intraoperatória é obrigatória nas suspensões uterossacrais vaginais.
- A correção concomitante da incontinência urinária de esforço deve ser considerada quando diagnosticada clínica ou funcionalmente.

Recomendações

Recomendações para o tratamento cirúrgico do prolapso genital apical	Nível de evidência	Grau de recomendação
Toda cirurgia para prolapso uterino ou de cúpula vaginal deve incluir técnica de suspensão apical, independentemente da via cirúrgica.	I	A
A histerectomia vaginal isolada não deve ser realizada como tratamento exclusivo do prolapso genital apical.	I	A
A sacrocolpopexia deve ser considerada a técnica com maior durabilidade para correção do prolapso de cúpula vaginal, excetuando-se a colpocleise.	I	A
A sacrocolpopexia por via laparoscópica ou robótica apresenta eficácia semelhante à via aberta, com menor morbidade.	I	A
Técnicas vaginais com tecido nativo (fixação uterossacral, sacroespinal ou ileococcígea) são alternativas válidas em pacientes selecionadas ou com maior risco cirúrgico.	II	B
A cistoscopia intraoperatória é obrigatória nas suspensões uterossacrais vaginais para avaliação da perviedade ureteral.	I	A
A preservação uterina pode ser oferecida de forma segura em pacientes selecionadas, mediante decisão compartilhada.	II	B
A sacro-histeropexia é alternativa eficaz para mulheres que desejam preservação uterina, quando realizada por cirurgiões experientes.	II	B
A colpocleise é opção eficaz e segura para pacientes com prolapso apical avançado, alto risco cirúrgico e ausência de desejo de atividade sexual vaginal penetrativa.	I	A
A correção do hiato genital deve ser considerada quando alargado, independentemente da via cirúrgica utilizada.	II	B
A correção concomitante da incontinência urinária de esforço deve ser avaliada e discutida no planejamento cirúrgico.	I	A
O reconhecimento e a correção do componente apical em cistoceles avançadas reduzem significativamente o risco de recorrência.	I	A
A cirurgia de Manchester pode ser considerada em casos selecionados de prolapso uterino com alongamento cervical predominante.	II	B
Técnicas de suspensão na parede abdominal anterior podem ser utilizadas em cenários específicos, embora careçam de evidências de longo prazo.	III	C

Grau de recomendação: A – forte, B – moderada, C – baseada em consenso/opinião especializada. Nível de evidência baseado em: I – revisões sistemáticas, II – ensaios clínicos randomizados, III – estudos observacionais

Contexto clínico

O prolapso dos órgãos pélvicos (POP) é uma condição altamente prevalente, com impacto significativo na qualidade de vida das mulheres, especialmente após a

menopausa. Estima-se que até 50% das mulheres multiparas apresentem algum grau de prolapso e que cerca de 11% delas necessitarão de cirurgia corretiva ao longo da vida.^(1,2)

Entre os compartimentos acometidos, o prolapso genital apical assume papel central, uma vez que o suporte inadequado do ápice vaginal ou uterino compromete a eficácia e a durabilidade das correções realizadas nos compartimentos anterior e posterior. Estudos anatômicos demonstraram que o suporte apical corresponde ao nível I de DeLancey, formado principalmente pelos ligamentos uterossacros e cardinais, cuja falha resulta na descida do útero ou da cúpula vaginal.^(3,4)

A compreensão atual do POP reconhece que cistoceles e retoceles avançadas raramente ocorrem de forma isolada, estando frequentemente associadas a defeitos apicais não reconhecidos ou subtratados. A correção inadequada do compartimento apical constitui um dos principais fatores associados à recorrência cirúrgica.⁽⁵⁻⁷⁾

O prolapso genital apical é definido como a descida do compartimento apical da vagina em direção ao introito vaginal, podendo envolver o útero, o colo uterino em pacientes submetidas à histerectomia subtotal ou a cúpula vaginal após histerectomia total, bem como as alças intestinais, caracterizando a enterocele.⁽³⁾ Trata-se de condição prevalente, especialmente em mulheres múltiparas e idosas, com impacto significativo na qualidade de vida. O tratamento cirúrgico visa restaurar o suporte apical, aliviar os sintomas, prevenir a recorrência e preservar a função vaginal sempre que possível. Diversas técnicas cirúrgicas estão descritas, com abordagens obliterativas e reconstrutivas, por via vaginal, abdominal aberta, laparoscópica ou robótica.

Qual é técnica cirúrgica obliterativa para correção do prolapso apical?

A colpocleise constitui a principal cirurgia obliterativa, indicada para pacientes com prolapso apical avançado com ou sem útero (estádios III e IV), elevado risco cirúrgico e ausência de desejo de atividade sexual vaginal penetrativa. Pode ser realizada com ou sem histerectomia, desde que sejam excluídas afecções uterinas quando há preservação do útero.^(1,2,4)

Técnica operatória resumida: hidrodilatação com solução vasoconstritora, exérese de retalho em retângulo da parede vaginal anterior (PVA) e posterior (PVP), mantendo-se faixa de vagina nas laterais; preservação da área suburetral da PVA para eventual futura cirurgia de *sling*, preservação da fâscia endopélvica, suturas com pontos separados aproximando as paredes vaginais usando poliglactina até o fechamento do canal e perineorrafia com redução do hiato genital.^(5,6)

As taxas de sucesso variam entre 90% e 98%, com baixa morbidade perioperatória e taxas baixas de recorrência.^(4,7-10) As complicações graves são raras, e os índices de arrependimento são mínimos quando a indicação é adequada.⁽⁸⁻¹⁰⁾ A histerectomia vaginal é associada a maior tempo cirúrgico e maior perda sanguínea.

O que são técnicas reconstrutivas e quais são elas?

São aquelas que reconstroem a anatomia, preservando o canal vaginal e, portanto, a atividade sexual vaginal penetrati-

va. São diversas técnicas que permitem a adequada fixação do compartimento apical.⁽¹¹⁾ São elas:

- Sacrocolpopexia, sacrocervicopexia, sacro-histeropexia.
- Fixação vaginal uterossacral e histeropexia uterossacral.
- Fixação vaginal sacroespinal e histeropexia sacroespinal.
- Fixação vaginal ileococcígea e histeropexia ileococcígea.
- Histeropexia ou colpopexia na parede abdominal anterior.
- Cirurgia de Manchester.

Sacrocolpopexia, sacrocervicopexia, sacro-histeropexia: como são feitas, quais os resultados e complicações?

Denomina-se sacrocolpopexia a suspensão da cúpula vaginal (nas histerectomizadas) ao ligamento longitudinal anterior do sacro, na quase totalidade das vezes utilizando-se tela. A sacrocervicopexia (em casos de histerectomia subtotal) e a sacro-histeropexia (ao se preservar o útero) são definidas como a suspensão do colo uterino ao ligamento longitudinal anterior do sacro por meio de tela.⁽¹¹⁾ Essas cirurgias são indicadas para a correção do prolapso uterino ou de cúpula vaginal em estádios II a IV, sintomáticas, com ou sem prolapso da PVA e PVP.⁽¹²⁾ A preservação do colo pode reduzir a incidência de exposição da tela.

A sacrocolpopexia é considerada o padrão-ouro para o tratamento do prolapso de cúpula vaginal, especialmente quando se busca maior durabilidade e menor risco de recorrência.⁽¹¹⁻¹⁵⁾ Consiste na fixação da cúpula vaginal, colo uterino ou útero ao ligamento longitudinal anterior do sacro por meio de tela sintética.

A via minimamente invasiva (laparoscópica ou robótica) apresenta eficácia semelhante à da cirurgia aberta, com menor morbidade, menor perda sanguínea e recuperação mais rápida.⁽¹⁶⁻¹⁸⁾ A cirurgia robótica, contudo, tende a apresentar maior tempo operatório, mas com vantagens como menor perda sanguínea e menor taxa de conversão em relação à laparoscopia, podendo ser especialmente útil em pacientes obesas ou com múltiplas cirurgias prévias.

A sacro-histeropexia é uma alternativa eficaz para mulheres que desejam preservar o útero, apresentando bons resultados anatômicos e funcionais quando bem indicada.^(14,16)

Técnica operatória resumida

Avaliação do espaço pré-sacral e viabilidade da fixação da tela ao promontório, abertura do retroperitônio, com identificação da artéria ilíaca comum direita, veia ilíaca comum esquerda, artéria ilíaca interna direita e ureter direito, acesso pelo espaço pararectal medial direito em direção ao colo uterino/cúpula vaginal, dissecação do espaço pré-sacral com isolamento do plexo hipogástrico superior do ligamento longitudinal anterior, evitando os vasos sacrais médios, dissecação de espaço retovaginal até o corpo perineal ou o músculo levantador do ânus, dissecação do espaço vesicovaginal até o nível do colo vesical, histerectomia supracervical quando indicada ou abertura do ligamento largo anterior e posterior com afastamento vesical, fixação de tela polipropileno em Y nas PVA e PVP, fixação com fio absorvível de

longa duração ou no istmo uterino, fixação da tela no promontório com fio inabsorvível e peritonização.

A sacrocolpopexia apresenta resultados superiores quando comparada aos reparos vaginais com tecido nativo para correção do prolapso apical.^(12,14)

As taxas de sucesso anatômico são elevadas nos acompanhamentos de curto e médio prazo, com índices de reoperação inferiores a 5% em séries consolidadas, o que confirma sua durabilidade e segurança.^(12,14)

Os resultados da sacro-histeropexia mostram melhora significativa dos sintomas e boa correção anatômica. Em metanálise recente, a sacrocolpopexia associada à histerectomia apresentou taxas ligeiramente mais altas de sucesso anatômico e subjetivo, em comparação à preservação uterina.⁽¹³⁾ No entanto, quando a sacro-histeropexia é realizada em pacientes bem selecionadas, os resultados são considerados satisfatórios e semelhantes em termos de alívio sintomático e melhora funcional.⁽¹⁶⁾

A sacrocolpopexia apresenta perfil de complicações potencialmente graves quando comparada aos reparos vaginais. Entre eles, hemorragia na região sacral, lesões intestinais, discite ou espondilodiscite em nível L5-S1, exposição ou erosão da tela. Dentre as estratégias preventivas, destacam-se o uso de telas de polipropileno ultraleves e a fixação da tela à vagina com suturas absorvíveis de longa duração.^(12,14) A histerectomia supracervical durante a sacrocolpopexia abdominal diminui o risco de erosão da tela, em comparação com a histerectomia total.⁽¹⁹⁾ A associação entre histerectomia e sacrocolpopexia não aumenta o risco global de complicações relacionadas à tela.⁽¹⁶⁾

Fixação vaginal uterossacral e histeropexia uterossacral: como são feitas, quais os resultados e complicações?

Têm por objetivo restaurar o suporte apical do útero ou da vagina em prolapso apicais sintomáticos em estádios I e II, ancorando-os aos ligamentos uterossacros no momento da histerectomia, com ou sem o uso de tela. Podem ser realizadas por via vaginal, laparoscópica, robótica ou, menos frequentemente, laparotômica.⁽¹¹⁾ É conhecida como cirurgia de High McCall.⁽⁶⁾ Em pacientes que desejam preservar o útero, a histeropexia uterossacral pode ser indicada. A cistoscopia intraoperatória é obrigatória nas suspensões vaginais, devido ao risco de obstrução ureteral, que ocorre em 4%-5% dos casos.⁽²⁰⁻²³⁾

Técnica operatória resumida

Identificação dos ligamentos uterossacros, sutura dos ligamentos (com fio inabsorvível como poliéster ou absorvível de longa duração ou poliglactina) próximo à espinha isquiatíca e da parede vaginal ipsilateral anterior e posteriormente (1 a 3 pontos). Alternativamente, pode-se realizar a sutura na linha média da PVP, no ligamento uterossacro ipsilateral, sutura transversa em peritônio até o ligamento uterossacro contralateral e, novamente, se exterioriza pela mucosa vaginal posterior (McCall). Na via alta, os ureteres

devem ser identificados e afastados do sítio de sutura no ligamento uterossacro à cúpula vaginal, devido à abertura do retroperitônio. Na preservação uterina, o colo ou a região ístmica é fixado aos ligamentos uterossacros

A taxa de cura ou satisfação varia entre 67% (prolapso estágio III) e 92% (prolapso estágio II).⁽²⁴⁾ A recorrência após a histeropexia geralmente é baixa. Em uma grande coorte prospectiva, a recorrência anatômica apical em um ano foi de 7,5% para a cirurgia de preservação uterina, em comparação com 17,2% para a histerectomia com suspensão da cúpula, com menor risco relativo ajustado para recorrência e falha na histeropexia. A histeropexia também foi associada a menor tempo operatório, menor hospitalização, menor uso de opioides e menos complicações do procedimento, sem diferenças nos desfechos funcionais ou de qualidade de vida entre os grupos.⁽²⁵⁾ Séries de casos de curto prazo de histeropexia uterossacral extraperitoneal relatam altas taxas de cura anatômica e subjetiva, baixas taxas de complicações e perda mínima do comprimento vaginal, embora esses dados exijam confirmação em estudos maiores e de longo prazo.⁽²⁰⁾

As complicações incluem hematomas, infecção e trombose venosa profunda. A obstrução ureteral que demanda remoção de sutura ocorre em aproximadamente 4%-5% dos casos.⁽²²⁾ Em médio e longo prazo, pode-se observar recorrência do prolapso.^(11,24) Encontrou-se 20% de infecção do trato urinário no pós-operatório da histeropexia uterossacral como evento adverso mais prevalente.⁽⁷⁾ Dor neuropática decorrente do aprisionamento neural foi relatada por 1,6% das pacientes, manifestando-se como dor em região glútea ou na face posterior da coxa, na distribuição S2-S4, sendo essa geralmente resolvida com tratamento medicamentoso ou remoção da sutura.^(22,23) Outras complicações abrangem lesão vesical (1%), agravos pulmonares (2%-3%) e cardíacos (<1%), íleo pós-operatório (0,1%) e obstrução do intestino delgado (0,8%).⁽²³⁾ Observa-se que a recorrência anatômica do prolapso, especialmente a relacionada ao alongamento cervical, é mais comum após histeropexia, em comparação à suspensão baseada em histerectomia, resultando em taxas mais elevadas de reoperação para correção da recorrência.⁽⁶⁾

Fixação vaginal sacroespinhal e histeropexia sacroespinhal: como são feitas, quais os resultados e complicações?

Nesses procedimentos, a vagina ou o útero são fixados ao ligamento sacroespinhal com fios inabsorvíveis ou com tela. A fixação vaginal sacroespinhal está indicada em pacientes com prolapso de cúpula vaginal sintomático, quando se opta pela cirurgia reconstrutiva via vaginal.⁽¹¹⁾ A histeropexia sacroespinhal está indicada em pacientes que desejam preservar o útero, com prolapso sintomático, quando se opta pela cirurgia reconstrutiva.⁽¹¹⁾

Técnica operatória resumida⁽²⁶⁾

Infiltração vaginal com solução vasoconstrictora, acesso ao ligamento sacroespinhal pela PVA (indicada nas cistoceles

concomitantes, a dissecação se inicia na fáscia pubocervical em direção ao arco tendíneo da fáscia pélvica, sendo posteriorizada na direção da espinha isquiática) ou PVP (mais rápido, após incisão vaginal na linha média, a fossa pararectal é dissecada até a espinha isquiática) com ou sem o uso de dispositivos (arpão de silicone ou agulha de Capiro), palpação e dissecação do ligamento sacroespinal. Quando não há uso de dispositivos, é necessário o uso de afastadores para passar os pontos, passagem de dois pontos ou fixação de arpão no ligamento sacroespinal, entre 1,5 cm e 2,0 cm mediais à espinha isquiática. A passagem das suturas pode ser feita bilateralmente (mandatória quando houver uso de tela) ou unilateralmente à direita, passagem dos fios, já conectados no ligamento, no ápice vaginal ou no colo uterino, caso seja utilizada tela, ela fica conectada nesses pontos, de modo bilateral, e então a tela é fixada na vagina ou no colo uterino, seguido do fechamento da vagina.

A taxa de sucesso inicial é alta (92,5%), mas a recorrência vai aumentando ao longo do tempo.⁽²⁷⁾ O risco de recorrência do prolapso de cúpula, ao utilizar a técnica vaginal sem tela, é maior que o risco de recorrência da sacrocolpopexia (11,3% vs. 7,9%). A longo prazo, a recorrência pode chegar a 33,3%.^(28,29) A taxa de sucesso da histerofixação é de 77,0%, semelhante às das cirurgias que removem o útero.⁽²⁷⁾

A dispareunia está descrita em 12,8% das pacientes que realizaram a fixação sacroespinal. Lesões teciduais (bexiga, ureter e intestino) estão relatadas em 4,95% dos casos; já as complicações gastrointestinais (como íleo e obstrução intestinal) ocorrem em 1,33% dos procedimentos. A infecção do sítio cirúrgico pode ocorrer em 3,30% dos casos, e a hemorragia está descrita em 0,95% das cirurgias.⁽²⁷⁾ Na histeropexia, as complicações são semelhantes àquelas que ocorrem com a fixação vaginal sacroespinal, porém a menor área de dissecação reduz o tempo operatório e pode reduzir lesões viscerais.⁽²⁸⁾

Fixação vaginal ileococcígea e histeropexia ileococcígea: como são feitas, quais os resultados e complicações?

Consistem na suspensão da cúpula vaginal ou do útero, fixando-os, com suturas, à fáscia do músculo ileococcígeo, também conhecida como fáscia pré-espinal, por situar-se mais caudal e medialmente à espinha isquiática.⁽²⁹⁾

É realizada por via vaginal e utiliza suturas absorvíveis ou permanentes, além de tecido nativo da paciente, sem o uso de telas sintéticas.⁽³⁰⁾ O uso da fáscia do músculo ileococcígeo para fixação uterina carece de avaliação extensa na literatura, sendo considerado uma variação técnica da colposuspensão ileococcígea, mas com preservação do útero.⁽³¹⁾ Essa técnica é pouco realizada no Brasil.

As principais indicações para a fixação vaginal ou da histeropexia ileococcígea incluem mulheres com prolapso apical, especialmente quando se busca evitar o uso de tela. Também é indicada para pacientes com contraindicação à cirurgia abdominal ou laparoscópica, bem como situações

em que se prioriza a manutenção do comprimento vaginal e da função sexual.

Técnica operatória resumida⁽³²⁾

Abertura da PVP até o fórnice, ou até a reflexão com o colo uterino, quando presente; dissecação do espaço retovaginal e identificação de eventual saco herniário de enterocoele. Na presença do útero, são necessárias a dissecação e a exposição adequada da face posterior do colo uterino, local em que serão ancoradas as suturas de suspensão ao colo uterino. Abertura e exposição da fossa pararectal através do pilar retal, uni ou bilateralmente, utilizando-se afastadores longos Breisky-Navratil. Diferentemente da histeropexia sacroespinal, na ileococcígea não é necessária a exposição até o complexo coccígeo-sacroespinal, e sim apenas até a fáscia do músculo ileococcígeo, que se situa caudal e medialmente à espinha isquiática. São passadas uma a duas suturas pelo ileococcígeo, podendo-se repetir no lado contralateral. A fixação bilateral é menos adequada para casos de suspensão uterina, em comparação à suspensão da cúpula vaginal, devido à dificuldade de aposição dos tecidos em ambos os lados. As suturas são, então, transfixadas pelo estroma cervical em sua porção mais distal, ou na cúpula vaginal, de modo a serem sepultadas com o fechamento da mucosa vaginal posterior. Ao se atarem as suturas, o colo uterino ou a cúpula vaginal são suspensos à fáscia ileococcígea. A suspensão deve ser simétrica, a fim de manter o eixo vaginal centralizado.

Em seguimento médio de cinco anos, relatam-se taxas de cura subjetiva de 88,6% e objetiva de 84,1%.⁽³³⁾ No acompanhamento de 10 anos, as taxas de sucesso global mantiveram-se em 74,4%.⁽³⁴⁾ Estudos comparativos apontam que, em relação à sacrocolpopexia abdominal, a ileococcígea apresenta tempo cirúrgico menor (78 vs. 140 minutos), com resultados anatômicos semelhantes e menores taxas de complicações.⁽³⁴⁾

Outro ponto relevante é a manutenção da função sexual. A maioria dos estudos sugere que, por preservar o comprimento vaginal, a técnica impacta menos negativamente na satisfação sexual do que a fixação sacroespinal. Contudo, algum encurtamento pode ocorrer, principalmente em casos de prolapsos avançados.^(31,35,36)

Diferentemente da suspensão de cúpula vaginal aos ileococcígeos, não se dispõe de literatura ampla para a histeropexia ileococcígea.^(33,37) Um único estudo de coorte retrospectivo, com seguimento mediano de quatro anos, descreve taxa de sucesso de 75,3% para prolapsos de estádios I e II e de 48% para prolapsos de estádios III e IV.⁽³⁷⁾ Os resultados da colpopexia ileococcígea, em associação à histerec-tomia são superiores aos da histeropexia nessa técnica.⁽³⁷⁾

Dentre as intercorrências mais comuns, destacam-se o sangramento intraoperatório, geralmente autolimitado, a lesão da parede retal, a laceração vascular adjacente ao músculo levantador do ânus⁽³⁸⁾ e a dor pélvica ou glútea transitória, menos prevalente do que na fixação sacroespinal.

No único estudo disponível sobre histeropexia ileococcígea, não foram registradas complicações intraopera-

tórias.⁽³¹⁾ Em contraste com a suspensão sacroespinhal, essa técnica proporciona maior distância das estruturas vasculonervosas de relevância clínica, normalmente localizadas próximas à espinha isquiática e ao complexo coccígeo-sacroespinhal.^(29,38)

Complicações graves, como lesões vasculares, uretrais ou neurológicas, são extremamente raras.^(31,35) No pós-operatório, relatam-se incidências de infecção urinária em aproximadamente 8% dos casos, dor glútea persistente por mais de quatro semanas em 1,4% e neuropatia nos membros inferiores, também em 1,4% dos casos.⁽³¹⁾

Histeropexia ou colpopexia na parede abdominal anterior: como são feitas, quais os resultados e complicações?

As técnicas de histeropexia ou colpopexia na parede abdominal anterior constituem alternativas cirúrgicas em situações selecionadas, particularmente em mulheres jovens com desejo de preservação uterina ou na presença de contraindicações à via sacral. Apesar de resultados iniciais promissores, essas técnicas ainda carecem de estudos com maior robustez metodológica para a consolidação de sua eficácia e segurança a longo prazo.⁽³⁹⁻⁴⁵⁾

São caracterizadas pela suspensão do colo uterino, istmo ou cúpula vaginal e, eventualmente, da camada fibromuscular da PVA na parede abdominal anterior, com ou sem a utilização de tela. Os pontos de fixação podem envolver o ligamento redondo, o ligamento pectíneo ou as regiões adjacentes à espinha ilíaca anterossuperior (EIAS).⁽¹¹⁾

As principais indicações incluem prolapso apical sintomático em mulheres que desejam preservar o útero, contraindicações à histerectomia, falha ou recorrência após cirurgias prévias de suspensão apical e situações em que a via sacral ou sacroespinhal não é preferida. Também pode ser considerada em centros nos quais a sacrocolpexia representa um maior desafio técnico.

Técnica operatória resumida

Histeropexia pelo ligamento redondo: consiste na passagem de suturas ou tela pelo ligamento redondo em sua inserção uterina, com extraperitonealização e fixação à fáscia da parede abdominal anterior. Podem ser utilizados enxertos autólogos de fáscia do reto ou sintéticos, posicionados bilateralmente, com as extremidades mediais introduzidas pela cavidade abdominal até a face posterior do útero, acima da inserção dos ligamentos uterossacros.^(39,40) A técnica pode ser realizada de forma unilateral, bilateral ou por plicatura dos ligamentos redondos.

Suspensão pelo ligamento pectíneo: realizada por via abdominal ou laparoscópica, acessa-se o espaço retropúbico para isolamento do ligamento pectíneo. Uma tela não absorvível é fixada à face anterior do colo uterino, com suas extremidades passadas bilateralmente através do ligamento pectíneo, promovendo elevação e estabilização uterina.^(41,42)

Histeropexia próxima à EIAS: emprega-se tela sintética fixada à face anterior do colo uterino e à camada fibro-

muscular da PVA, após a dissecação do espaço vesicovaginal. Os braços da tela são exteriorizados bilateralmente por meio de incisões a 4 cm posteriormente à EIAS e 2 cm acima da crista ilíaca, sendo, então, fixados de forma simétrica à parede abdominal anterior. O fechamento do peritônio sobre a tela é opcional, e a técnica pode ser realizada por via aberta ou laparoscópica.⁽⁴²⁻⁴⁴⁾

Embora os dados disponíveis sejam majoritariamente observacionais, os estudos relatam taxas elevadas de sucesso anatômico e funcional, especialmente em mulheres jovens com preservação uterina. Estudos de seguimento prolongado descrevem taxas de recorrência inferiores a 1% e elevados índices de satisfação,⁽⁴⁵⁾ além de resultados anatômicos satisfatórios em 87% dos casos após cinco anos.⁽⁴⁴⁾

A suspensão ao ligamento pectíneo apresentou taxa de recorrência de 5,1% após seguimento médio de 6,5 anos, com manutenção da viabilidade reprodutiva.⁽⁴¹⁾ Em comparação à sacrocervicopexia, a histeropexia na parede abdominal anterior demonstrou menor perda sanguínea, menor tempo cirúrgico e menores taxas de recorrência.⁽⁴⁰⁾ A fixação unilateral pelo ligamento redondo resultou em redução completa do prolapso em 76,4% dos casos e parcial em 21,8%.⁽³⁹⁾

Nas técnicas de suspensão lateral com tela, foram descritas taxas de sucesso anatômico de 88% no compartimento anterior, 86% no apical e 81% no posterior, com satisfação de 92,3% após seguimento médio de 7,5 anos.⁽⁴²⁾ Estudos comparativos demonstraram melhores desfechos anatômicos, maior satisfação e menor taxa de exposição de tela nos procedimentos com preservação uterina, em comparação àqueles associados à histerectomia.⁽⁴³⁾

As complicações intraoperatórias graves são raras. As intercorrências mais frequentemente descritas incluem dor pélvica ou dispareunia (até 0,36%), incontinência urinária de esforço *de novo* (12%), exposição ou erosão de tela (0,9% a 6,5%, significativamente menor nos procedimentos com preservação uterina) e recorrência do prolapso, variando de 0,7% a 12%, conforme a técnica e o tempo de seguimento.⁽⁴⁰⁻⁴⁵⁾ Relatos disponíveis sugerem segurança reprodutiva para gestações futuras após suspensão ao ligamento pectíneo.⁽⁴¹⁾

Cirurgia de Manchester: como é feita, quais os resultados e complicações?

Trata-se de cirurgia para prolapso uterino que inclui colporrafia anterior e posterior, amputação do colo do útero e fixação dos ligamentos cardinais na face anterior da cérvix.

⁽⁴⁶⁾ Indica-se a cirurgia de Manchester para mulheres com prolapso uterino associado ao alongamento do colo do útero (comprimento maior que 5 cm do canal endocervical) que desejam preservar a função reprodutiva e/ou uterina ou com comorbidades importantes.

Técnica operatória resumida⁽⁴⁶⁾

Incisão anterolateral na cérvix até o plano subepitelial, seguida de abertura da PVA na linha média, estendendo-se da incisão cervical até aproximadamente 3 cm do

meato uretral. Realiza-se dissecação da bexiga, separando-a do colo uterino até a junção uretrovesical e, lateralmente, até próximo aos ramos isquiopúbicos, bilateralmente. O complexo ligamentar cardinal-uterossacro é pinçado, seccionado, ligado e encurtado bilateralmente com fios de poliglactina. Procede-se, então, à amputação da cérvice. O prolapso da PVA é corrigido por meio do reparo da fásia pubocervical. Na sequência, os ligamentos cardinais e uterossacros são fixados anteriormente à face cervical com sutura em poliglactina, promovendo a suspensão uterina em direção à concavidade do sacro. Realiza-se a ressecção do excesso de mucosa da PVA, seguida de sutura, e a reepitelização do colo amputado com pontos de Sturmdorf. O procedimento é completado com o fechamento da PVA, colpografia posterior e correção da rotura do corpo perineal.

Em comparação à histerectomia vaginal, a cirurgia de Manchester não demonstrou diferença significativa quanto à satisfação das pacientes, apresentando taxa de cura do prolapso de 81% e satisfação global de 89%. O grupo submetido à histerectomia apresentou maior taxa de complicações graves (1,9% *versus* 0,2%; $p < 0,001$), além de maior tempo cirúrgico, maior perda sanguínea perioperatória e maior tempo de hospitalização.⁽⁴⁷⁾

Em série de pacientes com idade média de 48,7 anos, a cirurgia de Manchester apresentou taxa de sucesso anatômico de 97%, com índice de satisfação de 94,8%.⁽⁴⁸⁾ Quando comparada à histeropexia sacroespinhal, a cirurgia de Manchester demonstrou taxa de sucesso anatômico superior (87,3% *versus* 77%).^(49,50)

As complicações associadas à cirurgia de Manchester são geralmente pouco frequentes e de baixa gravidade. As mais descritas incluem infecção do trato urinário (11,5%), hematoma (0,9%), estenose cervical (0,5%), sangramento intraoperatório (0,5%) e infecção local (0,5%).⁽⁴⁹⁾

Como diferenciar o prolapso apical dos demais compartimentos?

O prolapso apical é identificado por exame ginecológico detalhado, com auxílio de espéculo vaginal, permitindo a visualização do colo uterino, da cúpula vaginal ou do fundo de saco. A descida caudal dessas estruturas durante a manobra de Valsalva caracteriza o comprometimento apical.⁽⁶⁾

Quando indicar a via vaginal, abdominal, laparoscópica ou robótica?

A escolha da via cirúrgica deve ser individualizada, considerando o tipo de prolapso, a idade, comorbidades, as cirurgias prévias, a experiência do cirurgião e os recursos disponíveis.

- Via vaginal: indicada em pacientes idosas, frágeis ou com alto risco cirúrgico. Técnicas como fixação sacroespinhal ou uterossacral apresentam bons resultados.
- Via abdominal aberta: atualmente reservada a casos específicos, como múltiplas cirurgias abdominais pré-

vias ou necessidade de procedimentos abdominais associados, devido à maior morbidade.^(17,18)

- Via laparoscópica: reproduz os princípios da sacrocolpopexia aberta, com menor morbidade, recuperação mais rápida e alta durabilidade, sendo a via preferencial em muitos centros.⁽¹²⁻¹⁴⁾
- Via robótica: apresenta eficácia semelhante à da laparoscópica, facilitando a sutura intracorpórea, porém com maior tempo cirúrgico e maior custo.^(17,18)

De forma geral, a sacrocolpopexia abdominal por via minimamente invasiva é considerada a técnica mais durável para o prolapso de cúpula vaginal.

A partir de que grau de cistocele deve-se suspeitar de prolapso apical associado?

Cistocelos acima do estágio 2 geralmente apresentam componente apical associado. A descida do ápice vaginal pode tracionar a PVA, simulando ou agravando a cistocele. O não reconhecimento desse componente apical está associado a maior risco de recorrência quando apenas a PVA é corrigida.⁽⁵¹⁾

A histerectomia vaginal isolada trata o prolapso apical?

Não. A histerectomia vaginal isolada não corrige o defeito de suporte apical e está associada a maior risco de prolapso de cúpula vaginal. Toda histerectomia realizada por prolapso deve ser acompanhada de técnica de suspensão apical, como fixação uterossacral ou sacroespinhal.⁽¹²⁾

Qual técnica indicar quando há necessidade de correção concomitante da incontinência urinária?

Em pacientes com incontinência urinária de esforço manifesta ou oculta, recomenda-se a correção concomitante à suspensão apical, geralmente com *slings* transobturatório ou retropúbico, reduzindo o risco de persistência ou o surgimento de novos sintomas. A decisão deve ser individualizada e compartilhada com a paciente.

O hiato genital deve ser corrigido concomitantemente, independentemente da via cirúrgica?

Sim. Em casos de hiato genital alargado, especialmente maior que 4 cm, recomenda-se correção concomitante, independentemente da via cirúrgica, devido à associação com maior risco de recorrência. Nesses casos, indica-se a colpoplastia posterior associada à perineorrafia.⁽⁵²⁾

Quando a cistoscopia deve ser realizada?

A cistoscopia é obrigatória nas cirurgias de fixação vaginal ou uterina aos ligamentos uterossacros. Deve ser realizada imediatamente após a confecção das suturas para confirmar a patência uretral bilateral; na ausência de jato urinário, a sutura deve ser reposicionada.⁽¹¹⁾

Quais são os principais cuidados pós-operatórios?

- Fazer repouso relativo nos primeiros dias.
- Evitar levantamento de peso (>5 kg) por seis a oito semanas.
- Evitar esforços que aumentem a pressão abdominal.
- Manter um bom funcionamento intestinal.
- Evitar relações sexuais por aproximadamente oito semanas.
- Observar sinais de infecção, sangramento anormal ou alterações urinárias.
- Seguir rigorosamente as orientações médicas quanto a medicações e acompanhamento.

Considerações finais

O prolapso genital apical exige diagnóstico preciso e correção cirúrgica adequada para melhorar a qualidade de vida e minimizar as recorrências. A escolha da técnica deve ser individualizada, com base em evidências científicas, características da paciente, experiência do cirurgião e recursos disponíveis. A correção adequada do suporte apical é o principal determinante do sucesso cirúrgico a longo prazo.

Referências

- Buchsbaum GM, Lee TG. Vaginal obliterative procedures for pelvic organ prolapse: a systematic review. *Obstet Gynecol Surv.* 2017;72(3):175-83. doi: 10.1097/OGX.0000000000000406
- Grzybowska ME, Futyma K, Kusiak A, Wydra DG. Colpocleisis as an obliterative surgery for pelvic organ prolapse: is it still a viable option in the twenty-first century? Narrative review. *Int Urogynecol J.* 2022;33(1):31-46. doi: 10.1007/s00192-021-04907-7
- Practice Bulletin No. 176: pelvic organ prolapse. *Obstet Gynecol.* 2017;129(4):e56-e72. doi: 10.1097/AOG.0000000000002016
- Hill AJ, Walters MD, Unger CA. Perioperative adverse events associated with colpocleisis for uterovaginal and posthysterectomy vaginal vault prolapse. *Am J Obstet Gynecol.* 2016;214(4):501.e1-e6. doi: 10.1016/j.ajog.2015.10.921
- Mueller MG, Ellimootil C, Abernethy MG, Mueller ER, Hohmann S, Kenton K. Colpocleisis: a safe, minimally invasive option for pelvic organ prolapse. *Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2015;21(1):30-3. doi: 10.1097/SPV.0000000000000114
- Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Prolapso dos órgãos pélvicos. *Femina.* 2025;53(7):920-7.
- Zebede S, Smith AL, Plowright LN, Hegde A, Aguilar VC, Davila GW. Obliterative LeFort colpocleisis in a large group of elderly women. *Obstet Gynecol.* 2013;121(2 Pt 1):279-84. doi: 10.1097/AOG.0b013e31827d8fdb
- FitzGerald MP, Richter HE, Siddique S, Thompson P, Zyczynski H; Ann Weber for the Pelvic Floor Disorders Network. Colpocleisis: a review. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct.* 2006;17(3):261-71. doi: 10.1007/s00192-005-1339-9
- Wheeler TL 2nd, Richter HE, Burgio KL, Redden DT, Chen CC, Goode PS, et al. Regret, satisfaction, and symptom improvement: analysis of the impact of partial colpocleisis for the management of severe pelvic organ prolapse. *Am J Obstet Gynecol.* 2005;193(6):2067-70. doi: 10.1016/j.ajog.2005.07.010
- Crisp CC, Book NM, Cunkelman JA, Tieu AL, Pauls RN; Society of Gynecologic Surgeons' Fellows' Pelvic Research Network. Body image, regret, and satisfaction 24 weeks after colpocleisis: a multicenter study. *Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2016;22(3):132-5. doi: 10.1097/SPV.0000000000000232
- Joint Report on Terminology for Surgical Procedures to Treat Pelvic Organ Prolapse. *Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2020;26(3):173-201. doi: 10.1097/SPV.0000000000000846
- Matthews CA. Minimally invasive sacrocolpopexy: how to avoid short- and long-term complications. *Curr Urol Rep.* 2016;17(11):81. doi: 10.1007/s11934-016-0638-7
- Maher C, Yeung E, Haya N, Christmann-Schmid C, Mowat A, Chen Z, et al. Surgery for women with apical vaginal prolapse. *Cochrane Database Syst Rev.* 2023;7(7):CD012376. doi: 10.1002/14651858.CD012376.pub2
- Gluck O, Blagjanje M, Veit-Rubin N, Phillips C, Deprest J, O'Reilly B, et al. Laparoscopic sacrocolpopexy: a comprehensive literature review on current practice. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2020;245:94-101. doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.12.029
- Moroni RM, Juliato CR, Cosson M, Giraudet G, Brito LG. Does sacrocolpopexy present heterogeneity in its surgical technique? A systematic review. *Neurourol Urodyn.* 2018;37(8):2335-45. doi: 10.1002/nau.23764
- Tius V, Arcieri M, Taliento C, Pellicchia G, Capobianco G, Simoncini T, et al. Laparoscopic sacrocolpopexy with concurrent hysterectomy or uterine preservation: a meta-analysis and systematic review. *Int J Gynaecol Obstet.* 2025;168(2):456-71. doi: 10.1002/ijgo.15891
- Chang CL, Chen CH, Chang SJ. Comparing the outcomes and effectiveness of robotic-assisted sacrocolpopexy and laparoscopic sacrocolpopexy in the treatment of pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J.* 2022;33(2):297-308. doi: 10.1007/s00192-021-04741-x
- Chang CL, Chen CH, Yang SS, Chang SJ. An updated systematic review and network meta-analysis comparing open, laparoscopic and robotic-assisted sacrocolpopexy. *J Robot Surg.* 2022;16(5):1037-45. doi: 10.1007/s11701-021-01329-x
- Nassif J, Yadav GS, Orejuela FJ, Turrentine MA. Rate of mesh erosion after sacrocolpopexy with concurrent supracervical compared with total hysterectomy: a systematic review and meta-analysis. *Obstet Gynecol.* 2022;140(3):412-20. doi: 10.1097/AOG.0000000000004901
- Ossin D, Ramirez-Caban L, Hurtado E. Extraperitoneal uterosacral ligament hysterectomy: a novel treatment for apical compartment prolapse. *Urology.* 2020;140:181-2. doi: 10.1016/j.urology.2020.02.026
- Unger CA, Walters MD, Ridgeway B, Jelovsek JE, Barber MD, Paraiso MF. Incidence of adverse events after uterosacral colpopexy for uterovaginal and posthysterectomy vault prolapse. *Am J Obstet Gynecol.* 2015;212(5):603.e1-7. doi: 10.1016/j.ajog.2014.11.034
- Flynn MK, Weidner AC, Amundsen CL. Sensory nerve injury after uterosacral ligament suspension. *Am J Obstet Gynecol.* 2006;195(6):1869-72. doi: 10.1016/j.ajog.2006.06.059
- Chung CP, Kuehl TJ, Larsen WI, Yandell PM, Shull BL. Recognition and management of nerve entrapment pain after uterosacral ligament suspension. *Obstet Gynecol.* 2012;120(2 Pt 1):292-5. doi: 10.1097/AOG.0b013e31826059f7
- Margulies RU, Rogers MA, Morgan DM. Outcomes of transvaginal uterosacral ligament suspension: systematic review and metaanalysis. *Am J Obstet Gynecol.* 2010;202(2):124-34. doi: 10.1016/j.ajog.2009.07.052
- Brennan EA, Scime NV, Huang B, Edwards AD, Kim-Fine S, Hall J, et al. Hysterectomy versus uterine preservation for pelvic organ prolapse surgery: a prospective cohort study. *Am J Obstet Gynecol.* 2025;232(5):461.e1-e20. doi: 10.1016/j.ajog.2024.10.021
- Declas E, Giraudet G, Delplanque S, Rubod C, Cosson M. How we perform a posterior sacrospinous ligament fixation by the vaginal route. *Int Urogynecol J.* 2020;31(7):1479-81. doi: 10.1007/s00192-019-04149-8
- McDonald J, Salehi O, Sathianathan N, Dowling C, Elmer S. Sacrospinous fixation versus uterosacral ligament suspension in managing apical prolapse. *World J Urol.* 2025;43(1):182. doi: 10.1007/s00345-025-05563-y
- Zhang W, Cheon WC, Zhang L, Wang X, Wei Y, Lyu C. Comparison of the effectiveness of sacrospinous ligament fixation and sacrocolpopexy: a meta-analysis. *Int Urogynecol J.* 2022;33(1):3-13. doi: 10.1007/s00192-021-04823-w
- Maher CF, Murray CJ, Carey MP, Dwyer PL, Ugoni AM. Iliococcygeus or sacrospinous fixation for vaginal vault prolapse. *Obstet Gynecol.* 2001;98(1):40-4. doi: 10.1016/s0029-7844(01)01378-3
- Suh DH, Jeon MJ. Risk factors for the failure of iliococcygeus suspension for uterine prolapse. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2018;225:210-3. doi: 10.1016/j.ejogrb.2018.05.001
- Krissi H, Stanton SL. Bilateral iliococcygeal fixation for vaginal vault prolapse and enterocele repair using a new suturing device--the digital needle driver. *BJOG.* 2005;112(8):1145-9. doi: 10.1111/j.1471-0528.2005.00616.x
- Shull BL, Capen CV, Riggs MW, Kuehl TJ. Bilateral attachment of the vaginal cuff to iliococcygeus fascia: an effective method of cuff suspension. *Am J Obstet Gynecol.* 1993;168(6 Pt 1):1669-74. doi: 10.1016/0002-9378(93)90676-a
- Serati M, Braga A, Bogani G, Maggiore UL, Sorice P, Ghezzi F, et al. Iliococcygeus fixation for the treatment of apical vaginal prolapse: efficacy and safety at 5 years of follow-up. *Int Urogynecol J.* 2015;26(7):1007-12. doi: 10.1111/j.1471-0528.2005.00616.x
- Serati M, Salvatore S, Athanasiou S, Scancarello G, Ghezzi F, Braga A, et al. Ten years' follow-up after iliococcygeus fixation for the treatment of apical vaginal prolapse. *Int Urogynecol J.* 2021;32(6):1533-8. doi: 10.1007/s00192-020-04598-6

35. Milani R, Cesana MC, Spelzini F, Sicuri M, Manodoro S, Fruscio R. Iliococcygeus fixation or abdominal sacral colpopexy for the treatment of vaginal vault prolapse: a retrospective cohort study. *Int Urogynecol J*. 2014;25(2):279-84. doi: 10.1007/s00192-013-2216-6
36. Olsen AL, Smith VJ, Bergstrom JO, Colling JC, Clark AL. Epidemiology of surgically managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence. *Obstet Gynecol*. 1997;89(4):501-6. doi: 10.1016/S0029-7844(97)00058-6
37. Braga A, Amato G, Caccia G, Papadia A, Treglia G, Scancarello C, et al. Iliococcygeus fixation for the treatment of vaginal vault prolapse: a systematic review and meta-analysis. *Minerva Urol Nephrol*. 2024;76(6):683-90. doi: 10.23736/S2724-6051.24.05818-X
38. Paz-Levy D, Yohay D, Neymeyer J, Hizkiyahu R, Weintraub AY. Native tissue repair for central compartment prolapse: a narrative review. *Int Urogynecol J*. 2017;28(2):181-9. doi: 10.1007/s00192-016-3032-6
39. Hsieh CH. A new laparoscopic technique for uterine prolapse: one-sided uterine fixation through the round ligament. *Int Urogynecol J*. 2011;22(2):213-9. doi: 10.1007/s00192-010-1269-z
40. Li S, Ji M, Zhao Z. The effectiveness of two different laparoscopic surgeries for apical support of pelvic organ prolapse. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2015;188:74-8. doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.03.007
41. Joshi VM, Otiv SR, Dagade VB, Borse M, Majumder RN, Shrivastava M, et al. Pectineal ligament hysteropexy for uterine prolapse in premenopausal women by open and laparoscopic approach in Indian urban and rural centers. *Female Pelvic Med Reconstr Surg*. 2015;21(4):215-9. doi: 10.1097/SPV.0000000000000179
42. Veit-Rubin N, Dubuisson JB, Lange S, Eperon I, Dubuisson J. Uterus-preserving laparoscopic lateral suspension with mesh for pelvic organ prolapse: a patient-centred outcome report and video of a continuous series of 245 patients. *Int Urogynecol J*. 2016;27(3):491-3. doi: 10.1007/s00192-015-2859-6
43. Veit-Rubin N, Dubuisson J, Constantini F, Lange S, Eperon I, Gomel V, et al. Uterus preservation is superior to hysterectomy when performing laparoscopic lateral suspension with mesh. *Int Urogynecol J*. 2019;30(4):557-64. doi: 10.1007/s00192-018-3678-3
44. Rimailho J, Talbot C, Bernard JD, Hoff J, Bécue J. L'hystéropexie antéro-latérale par voie abdominale. Résultats et indications. A propos d'une série de quatre-vingt-douze patients. *Ann Chir*. 1993;47(3):244-9.
45. Khanam RA, Rubaiyat A, Azam MS. Sling for correcting uterine prolapse: twelve years experience. *Mymensingh Med J*. 2014;23(1):13-7.
46. Skiadas CC, Goldstein DP, Laufer MR. The Manchester-Fothergill procedure as a fertility sparing alternative for pelvic organ prolapse in young women. *J Pediatr Adolesc Gynecol*. 2006;19(2):89-93. doi: 10.1016/j.jpag.2006.01.004
47. Bergman I, Söderberg MW, Kjeldgaard A, Ek M. Cervical amputation versus vaginal hysterectomy: a population-based register study. *Int Urogynecol J*. 2017;28(2):257-66. doi: 10.1007/s00192-016-3119-0
48. Liger Guerra C, Sabonet Morente L, Hidalgo Fernandez JM, Navarro Romero M, Gonzalez CE, Jimenez-Lopez JS. The Manchester procedure as a uterine-preserving alternative for uterine prolapse due to cervical elongation: a short- and mid-term clinical analysis. *Medicina (Kaunas)*. 2025;61(7):1183. doi: 10.3390/medicina61071183
49. Enklaar RA, Schulten SF, van Eijndhoven HW, Weemhoff M, van Leijzen SA, van der Weide MC, et al. Manchester procedure vs sacrospinous hysteropexy for treatment of uterine descent: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2023;330(7):626-35. doi: 10.1001/jama.2023.13140
50. Güler Çekiç S, Aktoz F, Urman B, Aydın S. A systematic review of uterine cervical elongation and meta-analysis of Manchester repair. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2024;300:315-26. doi: 10.1016/j.ejogrb.2024.07.029
51. Delancey JO. Surgery for cystocele III: do all cystoceles involve apical descent?: observations on cause and effect. *Int Urogynecol J*. 2012;23(6):665-7. doi: 10.1007/s00192-011-1626-6
52. Handa VL, Blomquist JL, Carroll MK, Muñoz A. Genital hiatus size and the development of prolapse among parous women. *Female Pelvic Med Reconstr Surg*. 2021;27(2):e448-e452. doi: 10.1097/SPV.0000000000000960

Marair Gracio Ferreira Sartori

Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

Luiz Gustavo de Oliveira Brito

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil

Lucas Schreiner

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

Aljerry Dias do Rego

Universidade Federal do Amapá, Macapá, AP, Brasil

Ana Selma Bertelli Picoloto

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

Andreisa Paiva Monteiro Bilhar

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Carlos Del Roy

Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP, Brasil

Daniela Siqueira Prado

Universidade Federal de Sergipe, SE, Brasil

Emerson de Oliveira

Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP, Brasil

Jorge Milhem Haddad

Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

Jussara Maria Valentim Cavalcante Nunes

Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI, Brasil

Leticia Maria de Oliveira

Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

Marilene Vale de Castro Monteiro

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil

Rafael Mendes Moroni

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil

Sergio Brasileiro Martins

Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

Conflitos de interesse: nada a declarar.**Disponibilidade dos dados:** os dados da pesquisa estão disponíveis no artigo.**Comissão Nacional Especializada em Uroginecologia e Cirurgia Vaginal****Presidente**

Marair Gracio Ferreira Sartori

Vice-presidente

Luiz Gustavo de Oliveira Brito

Secretário

Lucas Schreiner

Membros

Aljerry Dias do Rego

Ana Selma Bertelli Picoloto

Andreisa Paiva Monteiro Bilhar

Carlos Del Roy

Daniela Siqueira Prado

Emerson de Oliveira

Jorge Milhem Haddad

Jussara Maria Valentim Cavalcante Nunes

Leticia Maria de Oliveira

Marilene Vale de Castro Monteiro

Rafael Mendes Moroni

Sergio Brasileiro Martins